

אבחנת לשון ודופק: אינטגרציה בתשואול

בסיום התשואול אנו בוחנים את הלשון ומרגיש את הדופק: הדבר נעשה לא רק כדי לאשר את הדפוס או הדפוסים שזוהו במהלך התשואול, אלא גם כדי לבדוק האם הלשון והדופק מצביעים על קיומם של דפוסים שאינם ניכרים מהתסמינים הקליניים.

זה קורה לעתים קרובות בפועל וזהו הערך האמיתי של אבחון הלשון והדופק: אם אבחון הלשון והדופק היה משמש רק כדי לאשר אבחנה, לא היה טעם לבצע שלב זה. לעתים קרובות מאוד הלשון והדופק מוסיפים מידע יקר ערך לממצאים מהתשואול ואסור לעולם להתעלם מהם. לדוגמה, מטופל עשוי להתלונן על תסמינים שונים ואנו מאבחנים סטגנציה של צ'י הכבד: אם בלשון יש סדק עמוק של הלב, זה מראה לנו שלמטופל יש נטייה קונסטיטוציונלית לדפוסים של הלב ונטייה קונסטיטוציונלית להיות מושפע יותר מבעיות רגשיות. דוגמה טובה נוספת היא כאשר הדופק חלש מאוד בשני מיקומי הכליות (תופעה זו שכיחה במיוחד אצל נשים) ובכל זאת למטופל (במיוחד אם הוא עדיין צעיר) אין כל תסמינים של חוסר בכליות. אני תמיד רואה תמונת דופק כזו כמעידה על חוסר בכליות. אני לעולם לא מתעלם ממה שאני מוצא בדופק.

- שאלו על הבעיה המציגה, ותנו למטופל לדבר בחופשיות
- שאלו שאלות ספציפיות כדי לקבוע את הדפוס או הדפוסים הגורמים לבעיה או לבעיות המציגות, תוך ניסיון לקבוע במדויק את מועד הופעתן
- שאלו שאלות כדי לשלול או לאשר דפוסים אחרים
- שאלו שאלות נוספות, תוך התמקדות כללית ב-10 (או 16) השאלות
- שאלו על מחלות וניתוחים בעבר;
- התבוננו בלשון ובדקו את הדופק;
- שאלו על מחלות משפחתיות כגון אסטמה, אקזמה, מחלות לב;
- בררו על חייו הרגשיים של המטופל, חייו המשפחתיים ותנאי העבודה שלו, כדי לנסות לקבוע את הגורם למחלה

